

Fecha Última Actualización: 09-06-2022 2:10:47

Página 1 de 3

Información Paciente

Nombre : Amaro Trajano Alonso Da Silva
Edad : 72a 1m 27d
Dirección : El Tomillo 1877 Viña El Viñedo

Rut : 14.478.508-8
Fecha Nacto: 13/04/1950
Comuna : Puente Alto

N° Archivo : 9926649
Sexo : Masculino
Teléfono : 9 7130 0120

N° Epicrisis
310456

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Utim (5to Piso Mater)

Fecha Ingreso : 17/05/2022 00:11

Días Estadía: 23

Unidad de Egreso : Upc - Uci Adulto

Fecha Egreso : 09/06/2022 02:06

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

Sepsis

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

INGRESO UCI Módulo C-2
21 de mayo de 2022
Amaro Trajano Alonso Da Silva
RUT: 14.478.508-8
FI CASR : 17/05/2022
FI UTIM : 18/05/2022
FI UCI : 21/05/2021

Antecedentes:

Médicos: - HTA; DM2 NIR; ICC FE 45%, Taquicardia Ventricular (04/22) - Implante de DAI unicameral, FA en TACO, ERC en HDA trisemanal (L-M-V) por FAV BI 2ria a Enf poliquística renal, Asma remodelado, Obesidad

Fármacos: Furosemida; atorvastatina; TACO; brexotide + bromuro de ipatropio; carvedilol; amiodarona; Losartán.

Quirúrgico: Cx de Hartmann con reconstrucción de tránsito en 1997; prótesis cadera derecha + cambio de prótesis en 2012.

Alergias: Latex.

Hábitos: TBQ (++), OH (-), Drogas (-)

Inmunizaciones: 3 dosis

Paciente con antecedentes descritos. Reparación de FAV en hospitalización previa hace 1 semana. Cuadro de 48 horas de CEG, fiebre y desvanecimiento, además con sensación de descargas del DAI intermitente.

Ingresa con parámetros inflamatorios elevados (PCR 315, PQT 83.000).

Evoluciona con Shock séptico por lo que requirió Noradrenalina, se rescata HCs (+) a SAMS a las 9 y 10 horas.

Por gravedad y hospitalización reciente se inició vancomicina + imipenem.

Se realiza TAC TAP + TAC de EEII (18/05): TEP multisegmentario en arteria interlobar derecha con extensión parcial hacia la rama segmentaria lateral del LM y en rama segmentaria anterior del LSI. Sin signos tomográficos de sobrecarga derecha.

Dado urgencia dialítica y bacteriemia se decide no utilizar FAV (por probable puerta de entrada), se instala CHD femoral derecho para diálisis de agudos. Sin elementos sépticos en FAV.

Evaluable por UCO, se solicita Eco TE. que descarta vegetación en válvulas y DAI.

Se traslada a UTIM para continuar manejo.

Se desteta precozmente de DVA, se inicia Amiodarona y BB.

Fecha Epicrisis : 09/06/2022 02:10

Página 1 de 3

Fecha Última Actualización: 09-06-2022 2:10:47

Página 2 de 3

Evaluable por Infectología, se suspende Imipenem, por sospecha inicial de endocarditis en electrodo de DAI se sugiere iniciar Cloxacilina, Gentamicina y Rifampicina que llega a recibir 1 día.

Se realiza interrogación de DAI -> Sin descargas desde 12/2021

Se realiza Eco TT (20/05): Sin vegetación con aceptable visualización en válvulas y cable de DAI, FeVI 58%, dilatación leve de cavidades derechas.

Se pesquisa celulitis en región abdominal, se asume como puerta de entrada.

Se logra realizar diálisis de agudos el 20/05.

Se instala CVC con control radiográfico con dirección a carótida, en contexto de trombocitopenia y anticoagulación evoluciona con gran hematoma en región cervical y ESD, además con caída de Hb. Se suspende anticoagulación.

Evoluciona el 21/05 con nuevo Shock que se interpreta como séptico asociado a compromiso cuali-cuantitativo de conciencia, llega a requerir NA hasta 0.3 y Adrenalina hasta 0.15. Se volemiza con 1000cc de SF y albúmina 2 fcos, se pasa 1 fco de albúmina por acidosis.

Re-evaluado por UCO, ecocografía sin sobrecarga derecha, con contractilidad conservada, se descarta compromiso hemodinámico por TEP masivo.

Se define IOT realizado el 21/05 con TOT N° 8, premedicación: Fentanilo, etomidato, rocuronio, al primer intento, sin incidentes.

Se traslada a UCI para continuar manejo.

Diagnósticos:

- 1.FMO (hemodinámica, ventilatoria, coagulación)
- 2.Shock séptico 2° a Bacteriemia por SAMS
 - Foco indeterminado, obs foco cutáneo
 - Descartado foco valvular y de electrodo de DAI
- 3.TEP riesgo intermedio sin anticoagulación
- 4.Sd urémico - Urgencia dialítica
- 5.Antecedentes

Paciente en UCI tiene una evolución tórpida.

Cursa con cuadro séptico severo, bacteriemia por agalactiae. No logra salir adecuadamente del VMI y se tiene que traqueostomizar.

A pesar de tratamiento ATB el paciente no logra mejorar adecuadamente.

Hoy 08-06-22

Durante la tarde post diálisis el paciente presenta importante inestabilidad HDN. Con aumento de DVA que ya estaban altas basalmente.

Se pasa volumen con coíloides cerca 1500cc y se agrega adrenalina x BIC.

Cerca de las 22:30 aprox el paciente presenta severa hipotensión y taquicardia y luego f ibrilación ventricular. No se constata que su DAI descargue. Dada urgencia se decide desfibrilar ¿partiendo con 75 J y luego subiendo hasta 200 J. A ratos DAI del paciente descarga. Previamente se habían tomado exámenes que mostraron un HCT bajo de 18, previamente estaba con 20 por lo que se solicita de urgencia transfusión de 4 U GR. Resto de los exámenes eran normales. ELP normales.

En el intertanto se pasa coloide. DVA llegan a dosis muy altas 0,5 y 0,5 de NAD y de Adrenalina. El paciente entre y sale de taquicardia y fibrilación ventricular. Entre medio hace torcidas de puntas, se le pasa sulfato de magnesio, 100 cc de bicarbonato 2/3 M.

Se mantiene manejo activo por 65 minutos pero paciente no logra mejorar, hipotensión y desaturación sostenida.

Se avisa a familiares de la situación para que vengan a acompañarlo.

Se constata fallecimiento a las 02:00m AM del 09-06-22

Diagnóstico de Egreso

Shock séptico - FOM
Bacteriemia

Condición de Egreso Fallecido

fallecido

Egreso con Catéter Doble J:NO

Plan Post Alta

Fecha Epicrisis : 09/06/2022 02:10

Página 2 de 3

Fecha de Impresión : Martes, 05 de Mayo de 2026 15:30

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar

Indicaciones

Tipo de Reposo :

Régimen Alimentario :

Medicamentos :

Controles

INTERNO

Becado/Residente



Andres Aquevedo Salazar

Médico Tratante (Staff)